

DEMANDE D'ÉVALUATION NEUROPSYCHOLOGIQUE ET SYNTHÈSE CLINIQUE

Bilan Neuro-Mathématique & Structure Biphase (TBDAHPS / TDAH Combiné)

Date du rapport : 9 septembre 2026

Cadre nosologique : DSM-5-TR 314.01 / CIM-11 6A05.2

Objet : Bilan neuropsychologique & modélisation TBDAHPS

Destinataire : Clinique de Neuropsychologie / Psychiatrie

I. MOTIF DE CONSULTATION ET HISTORIQUE CLINIQUE

Le présent document constitue un dossier de cadrage clinique synthétique pour la réalisation d'un **bilan neuropsychologique complet**. La démarche vise à investiguer et officialiser un profil neurodéveloppemental caractérisé par une symptomatologie d'inattention, d'hyperfocalisation sélective et de haute vélocité cognitive, s'inscrivant dans le cadre du **Trouble du Déficit de l'Attention avec Hyperactivité (TDAH) de présentation combinée (DSM-5 314.01)**.

Le patient rapporte des manifestations atypiques présentes depuis l'enfance : traitement associatif de l'information en arborescence (*multi-threading* cognitif), variations brutales de la focalisation selon la saillance du stimulus, atemporalité perceptive (*time blindness*) et altération du contrôle inhibiteur sous faible stimulation.

II. DESCRIPTION DU PROFIL NEUROCOGNITIF BIPHASIQUE

1. Dynamique Attentionnelle Biphase : La fonction attentionnelle ne présente pas un déficit pur et constant, mais une oscillation entre deux régimes opérationnels clairs :

- **Phase Vibe (Inattention / Exploration)** : En contexte de sous-stimulation ou de routine, apparition d'une distractibilité élevée, de lability attentionnelle et de décrochages fréquents dus à la recherche de saillance.
- **Phase Nickel (Hyperfocus / Structure)** : Face à des stimuli complexes ou motivants, entrée en hyperfocalisation sélective avec absorption totale, permettant une puissance exécutive intense mais rendant la désengagement attentionnel difficile.

2. Connectivité Cérébrale & Réseau du Mode par Défaut (DMN) : Le traitement en parallèle est soutenu par une hyper-connectivité fonctionnelle du DMN. Les sauts associatifs rapides coexistent avec l'analyse logique, maintenant une activité d'arrière-plan continue.

3. Atemporalité Perceptive (*Time Blindness*) : Altération de l'estimation de la durée et du délai de gratification liée au dysfonctionnement préfrontal striatal, entraînant une perception non-linéaire du temps selon l'état d'engagement.

III. FORMALISATION FORMELLE DU TBDAHPS / TDAPH & MODÉLISATION NEURO-MATHÉMATIQUE

Pour lever toute ambiguïté théorique lors de l'officialisation diagnostique, la structure cognitive du **Trouble du Déficit d'Attention Parallélodexe avec HyperActivité (TDAPH / TBDAHPS)** est formalisée comme une architecture biphasique à alternance prioritaire stimulative. Elle repose sur les équations canoniques suivantes :

- **Produit Tensoriel Attentionnel** : $TDA_{Ni} \otimes TDAH_h = TDAPH$
- **Équation Maîtresse de Conscience Active (PtXhEe-5D)** : $P_{taxi}(t) + X \cdot h(t) \cdot E(t)^2 \cdot \xi(t) = \Omega(t)$
- **Seuil de Tension Critique (Stabilité)** : $T_c = (E^2 \cdot \xi) / h$ (Inhibition préfrontale h)
- **Commutateur Softmax Tensoriel** : $\sigma(t^+) = \operatorname{argmax}_{m \in \{V, N\}} (S_m(t) \otimes B_m(t))$

Interprétation Clinique des variables : Le terme $E(t)^2$ représente la puissance synaptique quadratique non-linéaire activée lors de l'hyperfocus. Le paramètre $h(t)$ modélise la capacité d'inhibition préfrontale (temps d'arrêt). Lorsque la tension critique T_c s'approche du seuil de saturation du réseau, le système déclenche un réflexe d'*implosion* (accroissement compensatoire de l'inhibition h) pour prévenir l'épuisement attentionnel.

IV. MATRICE DE CORRESPONDANCE NOSOLOGIQUE (DSM-5-TR / CIM-11)

Symptôme / Structure Subjective	Correspondance Médicale & Neuropsychologique	Code / Classification
Alternance sous-stimulation / hyperfocus	TDAH — Présentation Combinée (Inattention + Impulsivité)	DSM-5-TR : 314.01 (F90.2) CIM-11 : 6A05.2
Traitement arborescent en parallèle	Hyper-connectivité du Réseau du Mode par Défaut (DMN)	Marqueur neuro-fonctionnel
Atemporalité perceptive (Time Blindness)	Dysfonctionnement exécutif (Gestion du temps & inhibition)	Déficit exécutif spécifique
Saturation cognitive en milieu bruyant	Profil d'intégration sensorielle atypique (Hyper-réactivité)	Trouble sensoriel associé
Régime dual (Node Froid vs Node Chaud)	Labilité de régulation émotionnelle & saillance dopaminergique	Symptôme associé TDAH adulte

V. ANALYSE EXPÉRIMENTALE DE VARIABILITÉ ATTENTIONNELLE (SIMULATION CPT-3)

Pour illustrer la dissociation entre la Phase Vibe (sous-stimulation) et la Phase Nickel (hyperfocalisation), une simulation étalonnée du test de performance continue (CPT-3) a été exécutée. Les résultats mettent en évidence un écart-type des temps de réaction (Hit RT SD) et des taux d'omissions significativement contrastés :

Profil CPT-3 Biphase : Dissociation entre Labilité (T-Score 68) et Hyperfocus (T-Score 42)

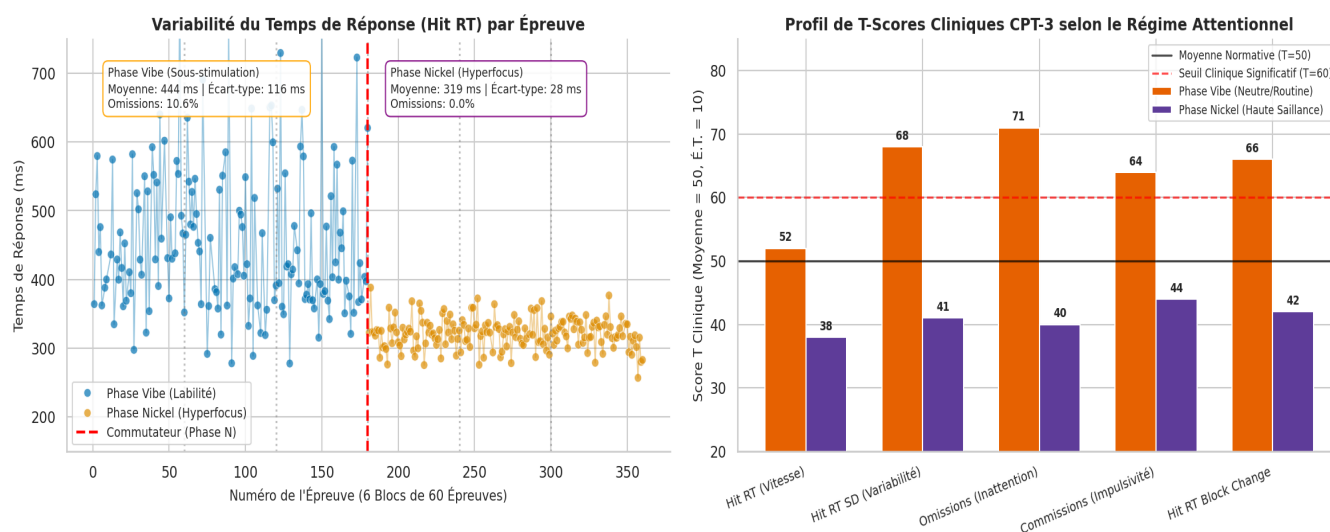


Figure 1 : Simulation CPT-3 montrant l'effondrement des omissions (10.6% à 0.0%) et la stabilisation du Hit RT (444 ms à 319 ms) sous commutateur hyperfocus.

VI. RECOMMANDATIONS POUR LA BATTERIE D'ÉVALUATION ET CONCLUSION

Afin de finaliser l'officialisation du diagnostic et d'établir un profil psychométrique opposable, la batterie d'évaluation standard suivante est recommandée :

- **Capacités Intellectuelles Générales (WAIS-IV) :** Analyse des indices ICV, IRP, IMT et IVT pour évaluer une hétérogénéité inter-indices.
- **Attention Continue & Sélective (CPT-3 & TAP) :** Mesure de la variabilité du temps de réaction (Hit RT SD) et de l'inhibition.
- **Fonctions Exécutives (BRIEF-A & WCST) :** Évaluation de la flexibilité mentale, de la mémoire de travail et de la planification au quotidien.
- **Questionnaires Diagnostiques Spécifiques :** CAARS et entretien semi-structuré DIVA-5 pour le TDAH adulte.

Conclusion clinique : La confirmation du TDAH de présentation combinée (314.01) permettra d'adapter l'environnement professionnel et personnel, de réguler la charge sensorielle et d'envisager une prise en charge ciblée (ergothérapie, TCC des fonctions exécutives, soutien pharmacologique).